

WhatsApp-Chatverlauf (Export)

Teilnehmer: Doreen Kahl, Anne Kahl (Schwester)

[16.06.26, 19:22:10] Doreen Kahl: Bescheid ist da. GdB 40. Kein Ausweis. Sie schreiben, die Behandlung laeuft ja noch.

[16.06.26, 19:25:44] Anne Kahl: Das ist doch verdreht. Erst sagen sie, es ist noch nicht fertig behandelt, und deshalb kriegst du weniger?

[16.06.26, 19:31:02] Doreen Kahl: So steht es da. Beim ersten Mal 2019 hatte ich sofort die 50, bis die fuenf Jahre rum waren.

[16.06.26, 19:33:18] Anne Kahl: Eben. Und jetzt ist es ein Rezidiv, neue OP im April. Frag den Rentenberater, ob das nicht wieder fuenf Jahre 50 sein muessen.

[20.06.26, 08:14:57] Doreen Kahl: Ich will nur nicht, dass die im Laden denken, ich komme nicht zurueck. Der Ausweis fuehlt sich wie ein Stempel an.

[20.06.26, 08:17:39] Anne Kahl: Der Ausweis ist Schutz, kein Urteil. Kuendigungsschutz, Zusatzurlaub, spaeter vielleicht Rente. Diagnose und Arbeitsfaehigkeit sind zwei Paar Schuhe.

[26.06.26, 20:41:22] Anne Kahl: Ich fahre dich am 14.07. zur Chemo. Danach zwei drei Tage ausruhen, ich bring Essen.

[26.06.26, 20:43:05] Doreen Kahl: Danke. Die Treppe schaffe ich nach der Chemo kaum. Arm links wird immer dicker.

[03.07.26, 17:05:11] Doreen Kahl: Brenner sagt, die neue Heilungsbewaehrung laeuft bis 2031 und der GdB muesste 50 sein. Widerspruch ist raus.

[03.07.26, 17:06:48] Anne Kahl: Gut. Dann kaempfen wir. Du machst das richtig.

Datei: 08_email_schwester.eml

Von	anne.kahl@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Fri, 26 Jun 2026 11:18:00 +0200
Betreff	Doreen will nicht als schwerbehindert abgestempelt werden

Guten Tag,

meine Schwester schwankt. Sie braucht den Ausweis für Schutz und vielleicht später Rente, will aber nicht, dass im Betrieb alle denken, sie kommt nicht zurück. Bitte erklären Sie ihr den Unterschied zwischen Diagnose, GdB und Arbeitsfähigkeit.

Ich fahre sie im Juli zur Chemo. Sie kann danach zwei bis drei Tage kaum die Treppe hoch.

Viele Grüße

Anne Kahl

Datei: eml/01_landesamt_eingangsbestaetigung.eml

Von	LAGuS MV - Widerspruchsstelle <widerspruch@lagus-mv.example.invalid>
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Wed, 01 Jul 2026 10:22:00 +0200
Betreff	Eingang Widerspruch GdB - Doreen Kahl, Az. SB 2026-40-2217

Sehr geehrter Herr Brenner,

wir bestaetigen den Eingang Ihres Widerspruchs gegen den Bescheid vom 16.06.2026 (Gesamt-GdB 40, keine Schwerbehinderteneigenschaft) in der Sache Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976.

Der Vorgang wird der versorgungsaerztlichen Stelle zur erneuten Bewertung vorgelegt. Wir bitten um Vorlage der vollstaendigen onkologischen Unterlagen zum Rezidiv, insbesondere zum Operationsdatum und zum Beginn der Systemtherapie, damit die Frage der erneuten Heilungsbewaehrung geprueft werden kann.

Bis zum Abschluss der Pruefung koennen Sie weitere Befunde nachreichen.

Mit freundlichen Gruessen

Im Auftrag

H. Radloff

Landesamt fuer Gesundheit und Soziales MV, Widerspruchsstelle

Datei: eml/02_tumorzentrum_befunduebersendung.eml

Von	Onkologisches Zentrum Rostock <ambulanz@onkozentrumsrostock.example.invalid>
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Thu, 25 Jun 2026 12:36:00 +0200
Betreff	Befunduebersendung Doreen Kahl - Rezidiv und Heilungsbewahrung

Sehr geehrter Herr Brenner,

auf Ihre Anforderung uebersende ich unseren Bericht vom 10.06.2026 sowie eine ergaenzende Stellungnahme (gesonderte Anlage) zu Frau Doreen Kahl.

Kurz zusammengefasst: Es liegt ein lokal-regionales Rezidiv des Mammakarzinoms links mit Befall axillaerer Lymphknoten vor. Die operative Entfernung erfolgte am 04.04.2026, die adjuvante Chemotherapie laeuft seit dem 12.05.2026, Bestrahlung und endokrine Therapie sind angeschlossen. Mit der erneuten operativen Geschwulstentfernung beginnt sozialmedizinisch eine neue Heilungsbewahrung.

An Funktionsfolgen bestehen ein Lymphoedem des linken Armes Grad zwei mit Bewegungseinschraenkung der Schulter, eine ausgepraegte Fatigue sowie eine beginnende Polyneuropathie der Finger. Ich bitte, diese Folgen und die erneute Erkrankung eigenstaendig zu wuerdigen und nicht die laufende Therapie pauschal gegen die Feststellung zu verwenden.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. med. Sabine Voigt

Onkologisches Zentrum Rostock

Datei: eml/03_bevollmaechtigter_heilungsbewaehrung.eml

Von	Uwe Brenner - Rentenberatung <rentenberater@example.invalid>
An	LAGuS MV - Widerspruchsstelle <widerspruch@lagus-mv.example.invalid>
Datum	Fri, 03 Jul 2026 15:18:00 +0200
Betreff	WG: Widerspruch GdB Doreen Kahl - erneute Heilungsbewaehrung, Az. SB 2026-40-2217

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Radloff,

anbei die angeforderten onkologischen Unterlagen. Die maßgeblichen Daten sind belegt: erneute operative Geschwulstentfernung am 04.04.2026, Beginn der adjuvanten Chemotherapie am 12.05.2026.

Damit ist durch das Rezidiv eine neue Heilungsbewaehrung ausgeloeset worden, die fuenf Jahre ab der Geschwulstentfernung, also bis zum 04.04.2031, laeuft. Waehrend dieser Heilungsbewaehrung ist der Teilverlust der Brust nach den Versorgungsmedizinischen Grundsuetzen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 zu bewerten. Das Lymphoedem des linken Armes Grad zwei tritt eigenstaendig hinzu.

Der angefochtene Bescheid bleibt mit einem Gesamt-GdB von 40 hinter diesem Heilungsbewaehrungssatz zurueck und verwendet die laufende Therapie zugleich als Anerkennungsgrund und als Begrenzung. Ich beantrage die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft ab Antragstellung sowie Akteneinsicht.

Mit freundlichen Gruessen
Uwe Brenner
Rentenberater (Rechtsdienstleistungsregister)

Datei: 04_therapiekalender.csv

datum	termin	folge	arbeitsausfall
2026-04-04	Operation axilläre Lymphknoten	Drainage und Schmerz	14 Tage
2026-05-12	Chemotherapie Zyklus 1	Übelkeit und Fatigue	7 Tage
2026-06-02	Chemotherapie Zyklus 2	Polyneuropathie Finger	9 Tage
2026-06-23	Chemotherapie Zyklus 3	Lymphödem verstärkt	offen
2026-07-14	Chemotherapie Zyklus 4 geplant	Transport durch Schwester	offen

Datei: 09_gdb_heilungsbewaehrung_zeitleiste.csv

phase	datum_beginn	datum_ende	ereignis	gdb_massgeblich	grundlage
Erstdiagnose	2019-04-08		Mammakarzinom links Erstdiagnose		Diagnosestellung
Ersttherapie	2019-05-20	2019-11-30	Brustoperation Chemotherapie Bestrahlung	50	Heilungsbewahrungssatz nach Geschwulstentfernung
Heilungsbewahrung eins	2019-05-20	2024-05-20	fuenf Jahre ohne Rezidiv	50	Heilungsbewahrung fuenf Jahre ab Geschwulstentfernung
Herabsetzung	2024-07-15		Ablauf Heilungsbewahrung ohne Rezidiv	30	Restfunktion nach abgelaufener Heilungsbewahrung
Rezidiv	2026-02-16		lokal-regionales Rezidiv axillaere Lymphknoten	Neubeginn	erneute Heilungsbewahrung wird ausgelost
Rezidivtherapie	2026-04-04	laufend	Operation Chemotherapie ab 2026-05-12 Bestrahlung geplant	50	neuer Heilungsbewahrungssatz nach Geschwulstentfernung
Heilungsbewahrung zwei	2026-04-04	2031-04-04	laufende Heilungsbewahrung nach Rezidiv	50	fuenf Jahre ab Geschwulstentfernung 2026-04-04
Bescheid	2026-06-16		festgestellter Gesamt-GdB streitig	40	Brustkrebs 40 Lymphoedem 20 psychisch 10 integrativ 40
Nachpruefung fruehestens	2031-04-04		Ende Heilungsbewahrung zwei	offen	fruehester Zeitpunkt einer Nachpruefung

Mandatsnotiz Onkologie und GdB

1. Mandantin

Mandantin ist Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976, Verkäuferin in einer Buchhandlung in Rostock. Brustkrebs links 2019, Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. GdB 50 wurde damals befristet festgestellt und 2024 nach Ablauf der Heilungsbewährung auf 30 herabgesetzt. Seit Februar 2026 Rezidiv in axillären Lymphknoten, erneute Therapie.

2. Verfahren

Änderungsantrag 18.03.2026. Bescheid 16.06.2026: Gesamt-GdB 40, keine Schwerbehinderteneigenschaft. Begründung: Therapie laufe, Funktionsfolgen noch nicht dauerhaft beurteilbar. Zugang 19.06.2026, Widerspruchsfrist bis 19.07.2026.

3. Auftrag

Widerspruch, vollständige Befundsammlung, Prüfung vorläufiger Nachteilsausgleiche und Abstimmung mit Arbeitsunfähigkeit, Krankengeld, Reha und möglicher Erwerbsminderung. Das Ergebnis offen halten: Es geht um Funktionsfolgen, Rezidivlage und Zeitraum, nicht um eine automatische Dauerfeststellung.

Onkologiebericht

1. Diagnose und Verlauf

Onkologisches Zentrum Rostock, Bericht 10.06.2026. Lokal-regionales Rezidiv Mammakarzinom links, axilläre Lymphknoten, Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ. Therapie: Operation 04.04.2026, adjuvante Chemotherapie ab 12.05.2026, anschließend Bestrahlung und endokrine Therapie geplant.

2. Funktionsfolgen

Lymphödem linker Arm Grad 2, Bewegungseinschränkung Schulter links, ausgeprägte Fatigue, Polyneuropathie an Fingern nach erster Chemogabe, Übelkeit, Schlafstörungen. Ärztliche Empfehlung: keine stehende Vollzeittätigkeit, keine Lasten über 5 kg links, Reha nach Abschluss der Bestrahlung.

3. Prognose

Therapie kurativ intendiert, Rückfallrisiko erhöht. Die Ärztin bittet um Berücksichtigung der erneuten Erkrankung und der gegenwärtigen Therapiebelastung.

Bescheid GdB 40

1. Entscheidung

Das Landesamt stellt einen Gesamt-GdB von 40 ab 18.03.2026 fest. Eine Schwerbehinderteneigenschaft wird nicht anerkannt.

2. Begründung

Die Behörde bewertet Brustkrebserkrankung nach Rezidiv und Therapiebelastung mit Einzel-GdB 40, Lymphödem mit 20 und psychische Belastung mit 10. Eine höhere Bewertung sei wegen noch nicht abgeschlossener Behandlung nicht möglich.

3. Auffälligkeit

Die Behörde verwendet die laufende Therapie zugleich als Anerkennungsgrund und als Begrenzung. Der Onkologiebericht zur Rezidivsituation und die konkreten Einschränkungen im Armgebrauch werden nicht erkennbar vertieft.

Arbeitgebernotiz Buchhandlung

1. Tätigkeit

Doreen Kahl arbeitet normalerweise 30 Wochenstunden im Verkauf, Wareneingang und Veranstaltungsservice. Sie trägt Bücherkisten, räumt Regale, steht an der Kasse und betreut Lesungen.

2. Einschränkungen

Seit Mai 2026 sind Kistenheben, längeres Stehen und Abendveranstaltungen kaum möglich. Kolleginnen übernehmen Wareneingang. Die Arbeitgeberin bietet reduzierte Stunden, kann aber keine reine Sitzkasse garantieren.

3. Bedeutung

Die Notiz zeigt konkrete Teilhabefolgen. Für den GdB ist nicht der Arbeitsplatz allein maßgeblich, aber die Funktionsfolgen werden dadurch greifbar: Armgebrauch, Fatigue, Belastbarkeit, Infektionsschutz und Wege zu Therapie.

Widerspruchsentwurf GdB Krebsrezidiv

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 16.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft ab Antragstellung, hilfsweise erneute Entscheidung nach Beiziehung der vollständigen onkologischen Unterlagen.

2. Begründung

Die Behörde hat Rezidiv, laufende Systemtherapie, Lymphödem, Fatigue und konkrete Funktionsfolgen nicht hinreichend zusammengeführt. Gerade die erneute Erkrankung nach früherer Heilungsbewährung verlangt eine eigenständige Bewertung. Die laufende Therapie darf nicht pauschal gegen die Feststellung verwendet werden, wenn die Teilhabebeeinträchtigung bereits aktuell erheblich ist.

3. Beweismittel

Onkologiebericht, Therapiekalender, Lymphödemtherapie, Arbeitgebernotiz, Fotos Kompressionsversorgung, Befund Psychoonkologie und Reha-Antrag.

Reha, Krankengeld und Rentenbezug

1. Gegenwärtige Leistungen

Die Mandantin bezieht Entgeltfortzahlung, danach voraussichtlich Krankengeld. Onkologische Reha ist nach Bestrahlung geplant. Versicherungsverlauf zeigt 31 Jahre Pflichtbeiträge, Kinderberücksichtigungszeiten und Teilzeitphasen.

2. Rentenberaterliche Prüfung

Kurzfristig steht GdB-Widerspruch und Reha im Vordergrund. Mittelfristig: Nahtlosigkeitsrisiko, Erwerbsminderungsrente nur bei fortbestehender Leistungsminderung, Altersrente schwerbehinderter Menschen wegen Alter noch fern. Die Dokumente sollten dennoch so sortiert werden, dass später keine Therapielücken und Funktionsfolgen verloren gehen.

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

Versorgungsärztliche Stelle

Aktenzeichen: SB 2026-40-2217

Versorgungsärztliche gutachterliche Stellungnahme nach Aktenlage

Datum: 10.06.2026

Betroffene: Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976

Formathinweis für den Export: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Auftrag

1.1 Zu bewerten ist der Änderungsantrag vom 18.03.2026. Bisher festgestellt war ein Grad der Behinderung von 30 nach abgelaufener Heilungsbewährung.

1.2 Grundlage sind der Kurzbefund des behandelnden Onkologischen Zentrums sowie die Angaben der Antragstellerin. Eine persönliche Untersuchung ist nicht erfolgt.

Funktionsbeeinträchtigungen und Einzelbewertung

2.1 Für die Brustkrebserkrankung nach Rezidiv und die gegenwärtige Therapiebelastung wird ein Einzel-Grad der Behinderung von 40 angesetzt.

2.2 Das Lymphödem des linken Armes wird mit einem Einzel-Grad der Behinderung von 20 bewertet, die psychische Belastung mit 10.

Bildung des Gesamt-Grades der Behinderung

3.1 Aus dem führenden Wert 40 und den hinzutretenden Beeinträchtigungen wird integrativ ein Gesamt-Grad der Behinderung von 40 gebildet.

3.2 Eine höhere Bewertung ist nach hiesiger Auffassung derzeit nicht möglich, weil die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist und die dauerhaften Funktionsfolgen noch nicht sicher beurteilt werden können.

Anmerkung

4.1 Diese Stellungnahme bewertet die Erkrankung als noch nicht abgeschlossen behandelt. Die Frage, ob durch das Rezidiv mit erneuter operativer Geschwulstentfernung am 04.04.2026 eine neue Heilungsbewährung mit einem eigenständigen Bewertungssatz ausgelöst worden ist, wurde hier nicht abschließend geprüft und sollte im Widerspruchsverfahren nachgeholt werden.

gez. Dr. med. R. Petermann

Versorgungsärztliche Stelle, LAGuS Mecklenburg-Vorpommern

Onkologisches Zentrum Rostock

Schwerpunktpraxis für Hämatologie und Onkologie

Südring 81, 18059 Rostock

Ergänzende sozialmedizinische Stellungnahme zur Heilungsbewährung

Datum: 24.06.2026

Patientin: Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976

Formathinweis für den Export: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Anlass

1.1 Diese Stellungnahme ergänzt unseren Bericht vom 10.06.2026 und dient der Vorlage im Widerspruchsverfahren gegen den Feststellungsbescheid vom 16.06.2026.

Diagnose und Behandlungsverlauf

2.1 Es liegt ein lokal-regionales Rezidiv eines Mammakarzinoms links mit Befall axillärer Lymphknoten vor, hormonrezeptorpositiv, HER2-negativ.

2.2 Die operative Entfernung des Rezidivs erfolgte am 04.04.2026. Seit dem 12.05.2026 läuft eine adjuvante Chemotherapie; Bestrahlung und endokrine Therapie sind angeschlossen.

2.3 Die Ersterkrankung war 2019 operativ, chemotherapeutisch und strahlentherapeutisch behandelt worden; die damalige Heilungsbewährung war ohne Rezidiv abgelaufen, weshalb der Grad der Behinderung 2024 auf 30 herabgesetzt worden war.

Sozialmedizinische Einordnung der Heilungsbewährung

3.1 Mit der erneuten operativen Geschwulstentfernung am 04.04.2026 beginnt sozialmedizinisch eine neue Heilungsbewährung. Diese läuft regelhaft fünf Jahre, im vorliegenden Fall damit bis zum 04.04.2031.

3.2 Während dieser Heilungsbewährung ist die Erkrankung nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 zu bewerten. Eine Herabstufung während der laufenden Heilungsbewährung wäre nicht sachgerecht.

Funktionsfolgen unabhängig von der Heilungsbewährung

4.1 Es besteht ein Lymphödem des linken Armes Grad zwei mit schmerzhafter Bewegungseinschränkung der Schulter und einer Belastungsgrenze von etwa fünf Kilogramm.

4.2 Hinzu treten eine ausgeprägte tumor- und therapiebedingte Fatigue, eine beginnende Polyneuropathie der Finger sowie Schlafstörungen. Eine stehende Vollzeittätigkeit ist derzeit nicht leidensgerecht.

Ergebnis

5.1 Aus onkologischer Sicht ist die erneute Erkrankung eigenständig zu bewerten. Der Heilungsbewährungssatz von mindestens 50 begründet die Schwerbehinderteneigenschaft; die laufende Therapie spricht nicht gegen, sondern für eine erhebliche gegenwärtige Teilhabebeeinträchtigung.

gez. Dr. med. Sabine Voigt

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie